Exemple de compte rendu de lymphoscintigraphie des membres inférieurs

Compte rendu réel anonymisé (identité, âge et date supprimés) — modèle de rédaction

À RETENIR

- Indication type : **lymphœdème d'un membre inférieur** (ici gauche).
- Traceur : ^{99m}Tc-nanocolloïdes, **1 mCi (37 MBq)**, injection dans le **1er espace interdigital**, bilatérale.
- Acquisition : **balayage corps entier** antérieur + postérieur à **30 min** et **2 h** post-injection.
- Signes d'insuffisance lymphatique : absence de trajet lymphatique, retard de visualisation ganglionnaire (seulement au temps tardif), **reflux dermique** (rétention au pied qui s'intensifie au temps tardif).
- Côté sain : trajet lymphatique unique antéro-interne, relais inguino-cruraux et lombo-aortiques qui augmentent au temps tardif.
- Visualisation d'un **relais poplité** = sollicitation du **réseau profond** (à explorer).
- Fixation hépatique et rénale = physiologique (à signaler en « À noter »).

I. Indication

- Lymphœdème du membre inférieur gauche.

II. Protocole

- Injection de **01 mCi** de nanocolloïdes marqués au ^{99m}Tc dans le 1er espace interdigital des deux mains **[à vérifier]** *à vérifier : pour les membres inférieurs, l'injection se fait dans le 1er espace interdigital des deux pieds*.
- Balayage corps entier (face antérieure et postérieure) à **30 min** et **2 h** post-injection.

III. Résultats (images précoces et tardives)

1. Membre inférieur gauche

- Absence d'individualisation de trajet de migration lymphatique.
- Absence de visualisation de relais ganglionnaires au temps précoce, avec visualisation de 2 ganglions inguino-cruraux et 1 lombo-aortique au temps tardif.
- Rétention du radiotraceur au niveau du pied qui s'intensifie au temps tardif, en rapport avec un **reflux dermique**.

2. Membre inférieur droit

- Bonne migration du radiotraceur avec visualisation d'un trajet lymphatique unique antéro-interne.
- Visualisation de relais ganglionnaires inguino-cruraux et lombo-aortiques qui augmentent en nombre et en intensité au temps tardif.
- Mise en évidence d'un relais ganglionnaire **poplité** qui augmente en nombre et en intensité au temps tardif, en rapport avec une sollicitation du réseau profond.

À noter — Visualisation d'une fixation hépatique et rénale d'allure physiologique.

IV. Conclusion

Aspect scintigraphique en faveur de :

- **Insuffisance lymphatique sévère à gauche**.

- Bonne migration à droite avec visualisation du relais ganglionnaire poplité, en rapport avec une sollicitation du réseau profond, à explorer.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quel radiopharmaceutique et quelle activité sont utilisés dans ce protocole ?	^{99m}Tc-nanocolloïdes, 1 mCi.
2. À quels temps sont réalisés les balayages corps entier ?	30 min et 2 h post-injection, faces antérieure et postérieure.
3. Que traduit une rétention au pied qui s'intensifie au temps tardif ?	Un reflux dermique.
4. Que traduit la visualisation d'un relais poplité ?	Une sollicitation du réseau lymphatique profond.
5. Quels signes orientent vers une insuffisance lymphatique sévère ?	Absence de trajet lymphatique, ganglions visibles seulement au temps tardif, reflux dermique.
6. Quelles fixations sont physiologiques sur le balayage ?	Hépatique et rénale.